

Nr. 117 Kommissarische Besprechung im Reichsjustizministerium vom 19. März 1935, 10.30 Uhr

R 22/454, Bl. 106–109 Niederschrift durch AGR Maßfeller/RJuM¹
Druck: SCHUBERT, Familien- und Erbrecht, S. 28–31.

Anwesend: MD Volkmar (Vorsitz), MR Brandis, AGR Maßfeller (RJuM); ORR Globke, Linden (RIM); Prof. Behrens (RErzM); Prof. Blome (StdF).

Beginn: 10:30

Ort: Reichsjustizministerium

VERHINDERUNG EUGENISCH UNERWÜNSCHTER EHEN, EINFÜHRUNG VON EHEGESUNDHEITS-ZEUGNISSEN.

Der Vorsitzende wies in seiner Einleitung darauf hin, daß nach dem geltenden Recht des Bürgerlichen Gesetzbuches jeder Erbkranker, der nicht geschäftsunfähig sei, eine Ehe schließen könne. Auch diejenigen Personen, deren Unfruchtbarmachung nach dem Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses² erfolgen müsse, könnten heiraten, noch bevor ihre Unfruchtbarmachung durchgeführt sei. Es sei ja bekannt, daß in mehreren Fällen von dieser Möglichkeit auch Gebrauch gemacht worden sei. Die Notwendigkeit einer Änderung des materiellen Eheschließungsrechts des Bürgerlichen Gesetzbuches sei deshalb wohl anzuerkennen. Man werde daran denken müssen, ein Eheverbot für die nicht sterilisierten Erbkranken zu schaffen. Darüber hinaus sei wohl auch ein Verbot der Eheschließung für die wegen Geistesschwäche und Trunksucht entmündigten Personen gerechtfertigt. Ein großer Teil der wegen Geistesschwäche und Trunksucht entmündigten Personen werde unter das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses fallen und deshalb von dem für Erbkranker zu schaffenden Eheverbot erfaßt werden. Aber auch in den Fällen, in denen eine erbliche Belastung des Geistesschwachen nicht feststellbar sei oder die Unfruchtbarmachung eines wegen Trunksucht Entmündigten trotz der Vorschrift des § 1 Abs. 3 des Gesetzes vom 14. Juli 1933 nicht erfolgen könne³, sei ein Eheverbot gerechtfertigt, da nicht erwartet werden könne, daß diese Personen eine rechte Ehe führen und gesunden Nachwuchs erzeugen würden.

¹ Zu der Besprechung hatte das RJuM mit Schreiben vom 6. 3. 35 den StdF, RIM und RErzM eingeladen und den Themenkreis dabei wie folgt umrissen: „Nach dem zur Zeit geltenden Recht kann die Schließung einer aus eugenischen Gründen unerwünschten Ehe nicht verhindert werden. Mit Recht ist darauf hingewiesen worden, daß es mit den Zwecken des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses nicht vereinbar ist, wenn ein Erbkranker noch vor der Durchführung der Unfruchtbarmachung heiratet. Ebenso unerwünscht ist es, daß Personen, die wegen Geistesschwäche oder aus anderen Gründen entmündigt sind oder an einer mit Ansteckungsgefahr verbundenen Geschlechtskrankheit leiden, heiraten dürfen. Eine Änderung des materiellen Eheschließungsrechts des BGB scheint mir hiernach schon vor der allgemeinen Neuordnung der familienrechtlichen Vorschriften erforderlich zu sein. Zum Zwecke der Feststellung, ob eine Heirat aus eugenischen Gründen zu verhindern ist, sowie zur Unterrichtung der Verlobten selbst wird die allgemeine Einführung von Ehegesundheitszeugnissen in Aussicht zu nehmen sein. Diese müßten vor der Eheschließung dem Standesbeamten vorgelegt und dem anderen Teil zur Kenntnis gebracht werden.“ R 22/454, Bl. 104 f. Vgl. auch APK II 3, Reg. Nr. 30416.

² Sog. *ErbgesundheitsG* vom 14. 7. 33 (RGBl. I S. 529); s. ARH I/1, Nr. 193 P. 7; KADEN/NESTLER, Dokumente I, Nr. 13.

³ § 1 (3) *ErbgesundheitsG* lautete: „Ferner kann unfruchtbar gemacht werden, wer an schwerem Alkoholismus leidet.“ Die Frage, ob ein Alkoholiker zu sterilisieren sei, sollte nicht nach der Menge des Alkoholkonsums entschieden werden, sondern nach der „Schwere der dem Alkoholismus zugrunde liegenden geistigen Abwegigkeit“. Die Bestimmung zielte demnach nicht auf Menschen, die in einer Lebenskrise zu Trinkern geworden waren, sondern „gegen die Verbreitung minderwertiger Erbanlagen, insbesondere z. B. der Anlage der Asozialität“; s. Kommentar bei PFUNDTNER/NEUBERT IV d, Nr. 3.

Neben einem Eheverbot für erblich schwer Belastete und für Entmündigte sei in Erwägung zu ziehen ein Eheverbot für solche Personen, die mit einem schweren mit Ansteckungsgefahr verbundenen Leiden behaftet seien. In Betracht kämen in erster Linie die an einer Geschlechtskrankheit und an schwerer Tuberkulose leidenden Personen. Diesen Personen eine Heirat schlechthin zu verbieten, sei wohl nicht angängig und auch nicht erforderlich. Man werde ihnen die Eingehung der Ehe auf Zeit verbieten müssen; wenn die Ansteckungsgefahr beseitigt sei, könne ihnen die Heirat gestattet werden.

Wenn man einer Änderung des materiellen Eheschließungsrechts in der bezeichneten Richtung nähertrete, dann erhöhe sich sofort die Frage, auf welchem Wege das Bestehen des Eheverbotes festgestellt werden solle. Daß dem Standesbeamten die Feststellung nicht überlassen bleiben könne, stehe fest. Die allein mögliche Regelung der Frage werde man in einer allgemeinen Einführung von Ehegesundheitszeugnissen zu erblicken haben. Deren Einführung sei schon in früheren Jahren erörtert worden. Gegen die Einführung seien in der Hauptsache 2 Gründe vorgebracht worden. Das Erfordernis eines Ehegesundheitszeugnisses, so sei gesagt worden, stelle einen Eingriff in die persönliche Freiheit der Verlobten dar und werde im Volke nicht verstanden werden. Zum anderen fehle es an einer ausreichenden Zahl von Ärzten, die mit den Erfahrungen der menschlichen Erblehre hinreichend vertraut seien, um die Verantwortung für die Ausstellung der Ehegesundheitszeugnisse übernehmen zu können. Beide Gründe seien heute nicht mehr durchschlagend. Der erste Grund entspringe der heute überwundenen liberalistischen Einstellung jener Zeit; heute werde das Volk die Notwendigkeit der Einführung von Ehegesundheitszeugnissen auch verstehen, denn sowohl durch den Unterricht in der Schule wie durch die Tagespresse sei die Bedeutung der Erbkrankheiten dem Volke klagemacht worden. Der zweite Grund entfalle, weil heute eine ausreichende Zahl von erbbiologisch geschulten Ärzten vorhanden sei; die Durchführung des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses habe dies gezeigt⁴. Die Gesundheitsämter, die am 1. April 1935 ihre Tätigkeit aufnehmen⁵, seien zur Ausstellung der Zeugnisse in der Lage.

Was den Inhalt der Ehegesundheitszeugnisse anlangt, so werde man prüfen müssen, welche Krankheiten in diesen offenbart werden dürften. Es sei nicht angängig, jede irgendwie geartete Krankheit in das Zeugnis aufzunehmen. Würde man so verfahren, so bestehe die Gefahr, daß die Verlobten von der Eingehung einer Ehe in größerem Umfange abgeschreckt würden, als aus bevölkerungspolitischen Gründen erwünscht sei. Der erforderliche Bevölkerungsnachwuchs sei gefährdet.

In der anschließenden Besprechung bestand Einverständnis darüber, daß nur solche Erbkrankheiten ein Ehehindernis bilden sollen, die in § 1 Abs. 2 des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses aufgezählt sind⁶. Oberregierungsrat Dr. Linden (M[inisterium] d[es] I[nnern]) wies darauf hin, daß der bevölkerungspolitische Ausschuß⁷ sich in seiner Sitzung am 11. März 1935 für eine Erweiterung des Kataloges der Erbkrankheiten ausgesprochen habe⁸. Man habe es insbesondere für erwünscht bezeichnet, daß auch Personen, die mit schweren erblichen Nervenleiden behaftet sind, sowie schwere Psychopathen, falls eine familiäre Belastung festgestellt sei, unfruchtbar gemacht würden. Auch auf diese Personen sollte sich das Eheverbot erstrecken. Demgegenüber wurde darauf

⁴ Vgl. die Zahlenangaben in Dok. Nr. 87 Anm. 16.

⁵ Die Errichtung staatlicher Gesundheitsämter in den Stadt- und Landkreisen war verankert im *Gesetz zur Vereinheitlichung des Gesundheitswesens* vom 3. 7. 34 (RGBl. I S. 531); s. ARH I/2, Nr. 376 P. 5. Zur Konzeption s. A. LABISCH/F. TENNSTEDT, Gesundheitsamt oder Amt für Volksgesundheit? Zur Entwicklung des öffentl. Gesundheitsdienstes seit 1933, in: FREI, Medizin und Gesundheitspolitik, S. 35–66.

⁶ Als Erbkrankheiten, bei deren Nachweis eine Sterilisierung vorgenommen werden sollte, listete § 1 (2) ErbgesundheitsG auf: 1. angeborener Schwachsinn, 2. Schizophrenie, 3. zirkuläres (manisch-depressives) Irresein, 4. erbliche Fallsucht, 5. erblicher Veitstanz (Huntingtonsche Chorea), 6. erbliche Blindheit, 7. erbliche Taubheit, 8. schwere erbliche körperliche Mißbildung. Vgl. SCHMUHLS. 156 f.

⁷ Arbeitsgemeinschaft II des „Sachverständigenbeirats für Bevölkerungs- und Rassenpolitik“ beim RIM, dieser gebildet im Juni 1933 und geleitet von dem Erbpsychiater Prof. Dr. Ernst Rüdin. Vgl. Dok. Nr. 27 Anm. 5.

⁸ Zu dieser Sitzung s. eingehend: POMMERIN, Sterilisierung, S. 71–77. Teilabdruck des Sitzungsprotokolls: KADEN/NESTLER, Dokumente II, Nr. 65. Vgl. APK I 1, Reg. Nr. 10666; APK II 3, Reg. Nr. 30368.

hingewiesen, daß man das Eheverbot so formulieren könne, daß jede Weiterung des Kataloges der Erbkrankheiten im Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses ohne weiteres ein Eheverbot für die Personen begründe, die mit einer in den Katalog aufgenommenen Krankheit behaftet seien. Oberreg. Rat Dr. Linden erklärte sich hiermit einverstanden.

Eine eingehende Erörterung wurde der Frage gewidmet, ob dem Erbkranken nach erfolgter Unfruchtbarmachung die Möglichkeit gegeben werden solle, auch eine erbgesunde Person zu heiraten. Der Vertreter des Ministeriums des Innern, Oberreg. Rat Dr. Linden, bezeichnete es als unerwünscht, daß erbgesunde und wegen Erbkrankheit sterilisierte Personen einander heiraten dürften; denn dann sei auch der erbgesunde Teil an der Fortpflanzung verhindert. Er vertrete die Auffassung, daß ein Erbkranker auch nach durchgeführter Unfruchtbarmachung nur wieder eine ebenfalls erkrankte Person heiraten dürfe. Demgegenüber wurde von dem Vorsitzenden darauf hingewiesen, daß es doch immerhin mißlich sei, Menschen voneinander zu trennen, die trotz der ihnen bekannten Mängel des anderen Teils einander heiraten wollten. Den Geschlechtsverkehr zwischen diesen Personen werde man nicht hindern können; auch werde es für den Erbkranken schwierig sein, einen ebenfalls erkrankten und sterilisierten Partner zu finden. Oberreg. Rat Dr. Linden glaubt, daß die zuletzt genannte Schwierigkeit sich dadurch beseitigen lassen werde, daß die Gesundheitsämter den Unfruchtbargemachten auf der Suche nach einem ebenfalls unfruchtbar gemachten Ehepartner unterstützen könnten. Im übrigen könne er darauf hinweisen, daß die Angehörigen der SS noch weit größeren Beschränkungen bei der Auswahl des Ehegatten unterworfen seien. Der Vertreter des Stellvertreters des Führers Prof. Dr. Blome bezeichnete es an sich für unerwünscht, daß ein Sterilisierter einen nicht Sterilisierten heirate. Er glaube aber nicht, daß man schon jetzt in dieser Richtung einen Zwang ausüben könne. Der Vergleich mit der SS sei seiner Auffassung nach nicht zwingend, da es sich bei der SS nur um einen verhältnismäßig geringen Bruchteil der Bevölkerung handle, um einen Orden, der sich besondere Aufgaben gestellt habe. An seine Mitglieder könnten und müßten deshalb höhere Anforderungen gestellt werden, als an das ganze Volk. Zur Zeit sei wohl eine Beschränkung am Platze. Folgender Regelung werde man zustimmen können: Vor durchgeführter Unfruchtbarmachung darf der Erbkranke nicht heiraten. Nach erfolgter Unfruchtbarmachung ist er ohne Beschränkung ehefähig, jedoch muß der andere Teil von der Unfruchtbarmachung Kenntnis erhalten. Aufgabe der Gesundheitsämter ist es dann, durch ihre beratende und aufklärende Tätigkeit zu erreichen, daß erbgesunde Menschen einen Erbkranken nicht heiraten. Er glaube, daß sich hierdurch schon viel erreichen lasse. Im übrigen sei doch auch damit zu rechnen, daß erbgesunde junge Menschen nur selten zur Eingehung der Ehe mit einem Sterilisierten bereit sein würden.

Einverständnis bestand darüber, daß auch ein Eheverbot für Personen geschaffen werden solle, die wegen Geistesschwäche und Trunksucht entmündigt sind. Ferner wurde es allseits gebilligt, daß Personen, die mit einem schweren, mit Ansteckungsgefahr verbundenen Leiden behaftet sind (Geschlechtskrankheiten, Tuberkulose), die Eingehung der Ehe auf Zeit verboten wird.

Schließlich herrschte Übereinstimmung darüber, daß in die Ehegesundheitszeugnisse außer den Leiden, die ein Ehehindernis begründen sollen, nur solche Leiden aufgenommen werden dürfen, die entweder für die Erbgesundheit der Nachkommen von erheblicher Bedeutung sind oder die infolge der mit ihnen verbundenen Ansteckungsgefahr die Gesundheit des anderen Ehegatten und deren Kinder gefährden. Wird ein solches Leiden festgestellt, dann soll in den Gesundheitszeugnissen von der Heirat abgeraten werden, die Entscheidung aber bei den Verlobten liegen.

Der Vorsitzende stellte zum Schluß die Übersendung eines Gesetzentwurfes in Aussicht⁹.

⁹ Am 11. 7. 35 übermittelte AGR Maßfeiler an ORR Globke/RIM den Referentenentwurf eines „Gesetzes gegen volksschädliche Ehen“; R 22/459, Bl. 94–96; s. auch APK II 3, Reg. Nr. 30582. Abdruck: SCHUBERT, Familien- und Erbrecht, S. 31 f. Er enthielt ein generelles Eheverbot für Personen, die entmündigt waren, unter vorläufiger Vormundschaft standen oder an einer ansteckenden Krankheit litten, außerdem grundsätzlich für jedermann, „solange gegen ihn ein Verfahren auf Unfruchtbarmachung schwebt“. Vor der Bestellung des Aufgebots sollte dem Standesbeamten ein Eheauglichkeitszeugnis des Gesundheitsamts vorzulegen sein. § 8 dieses Entwurfs, wonach das Gesetz Anwendung finden sollte, wenn auch nur ein Verlobter die dt. Staatsangehörigkeit

Maßfeller 25/3.

besaß, erklärte das AA in seiner Stellungnahme vom 15. 7. 35 als unvereinbar mit dem Haager Eheschließungsabkommen von 1902; R 22/459, Bl. 100–102. Zeitweise wurde erwogen, den „Erbschutz“, wie er mit diesem Gesetz bezweckt war, zusammen mit dem „Blutschutz“ (Verbot der Rassenmischehen) in *einem* Gesetz zu vereinigen, jedoch rückte man in den Besprechungen über die Nürnberger Gesetze während des Parteitags davon ab; hierzu und zum Fortgang s. Dok. Nr. 231.

Zitierhinweis

Nr. 117 Kommissarische Besprechung im Reichsjustizministerium vom 19. März 1935, 10.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d117>